

unisanté

Centre universitaire
de médecine générale
et santé publique • Lausanne

Répétitoires *Primary Care*

*Prof. Patrick Bodenmann, Unisanté
Dr Philippe Staeger, MER, Unisanté*



Unil

UNIL | Université de Lausanne

Programme

1. Torticolis (PB)
2. Fibromyalgie
3. Côlon irritable
4. Prescription de physiothérapie
5. Polyneuropathies (PS)
6. Grippe
7. Pied plat
8. Herpes-varicelle
9. Furoncle

Programme

1. Torticolis (PB)
2. Fibromyalgie
3. Côlon irritable
4. Prescription de physiothérapie
5. Polyneuropathies (PS)
6. Grippe
7. Pied plat
8. Herpes-varicelle
9. Furoncle

Références bibliographiques

Allan H. **Goroll**, Albert G. **Mulley**

“Primary care medicine”

Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia 2009 :

- Torticollis : chap 148, pg 1038-1042
- Fibromyalgie : chap 159, pg 1008-1013; **SURF** pg 484-485
- Côlon irritable : chap 74, pg 594-600
- Physiothérapie : consensus **PMU** et pratique clinique

Question 1

Quelle(s) affirmation(s) suivante(s) est/sont correcte(s) dans la prise en charge d'une **douleur à la nuque** avec une **raideur**, **sans déficit neurologique**, chez un patient de 56 ans ?

- ☒ A. Les examens de sang ne sont pas utiles
- ☐ B. Une radiographie de la colonne cervicale est utile dès 50 ans afin d'évaluer la présence d'arthrose
- ☐ C. Une imagerie par résonnance magnétique nucléaire est le premier examen de choix
- ☒ D. Le chaud, la glace et les massages permettent de diminuer le spasme musculaire
- ☐ E. Le port d'une collerette cervicale molle pour 6 semaines



La prise en charge suivante est recommandée lors d'un torticolis :

- Les **examens de sang** ne sont pas utiles, sauf si une infection est suspectée.
- Les **radiographies de la colonne cervicale** sont d'une valeur limitée; elles permettent parfois de confirmer la suspicion de maladies dégénératives, mais peu de corrélation avec les symptômes. En l'absence de situation traumatique, examen pas utile.
- L'**IRM** est le test de choix quand il y a une douleur accompagnée d'une compression neurologique persistante, surtout si les symptômes durent depuis plus de 6 à 12 semaines ou sont en aggravation.
- **Le chaud, la glace et les massages** permettent de diminuer le spasme musculaire. Pour soulager la douleur, les médicaments les plus utiles sont les AINS pour quelques jours.
- Une **collerette cervicale** peut être utilisée pour quelques jours, afin de reposer les muscles de la nuque. Par contre, un port prolongé doit être découragé, car il peut entraîner une faiblesse des muscles par atrophie d'immobilisation.

Question 2

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes au sujet de la **fibromyalgie** ?

- A. Il s'agit d'une maladie psychiatrique
- B. Le facteur rhumatoïde est positif dans la majorité des cas
- ☒ C. Le diagnostic repose sur le déclenchement de douleurs à la palpation de points spécifiques
- ☐ D. Les antidépresseurs font partie du traitement

Fibromyalgie

- Pathologie reconnue par l'OMS comme **maladie rhumatismale**.
- **Diagnostic difficile : non spécificité** des symptômes
(DD: arthrose, PR, collagénose, syndrome douloureux chronique...)
- **Critères diagnostiques :**
 - **Douleur** depuis plus de 3 mois affectant l'ensemble des quatre quadrants du corps
 - **Douleurs** électives lors de la palpation de ≥ 11 points douloureux sur 18
- **Traitement :**
 - Suivi médical régulier
 - Antalgie classique
 - Antidépresseur, antiépileptique
 - Physiothérapie



Question 3

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes au sujet de l'intestin irritable ?

- ☒ A. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes
- ☐ B. Il s'agit d'une maladie dont le diagnostic est posé par exclusion
- ☐ C. Une colonoscopie normale (pas de lésion spécifique) est nécessaire pour confirmer le diagnostic
- ☒ D. Le traitement est souvent difficile et comprend l'association de mesures médicamenteuses et non médicamenteuses

Intestin irritable

- Maladie fréquente dont les **mécanisme physiopathologiques** ne sont pas connus (activité myélo-électrique, hypersensibilité musculaire, sensibilité centrale à la douleur)
- **10 à 15%** de la population.
Rapport **femme**/homme : 2/1
- Statistiquement **associée aux maladies suivantes** :
troubles anxieux, dépression, trouble somatoforme douloureux, syndrome de fatigue chronique.



Intestin irritable

- **Critères diagnostiques :**

- **3 mois** ou plus dans les **12 derniers mois**, de symptômes continus ou récidivants de **douleur abdominale ou inconfort**,

- avec **2 facteurs parmi ces 3 :**

- soulagement par la défécation
- et/ou association avec un changement dans la fréquence des selles
- et/ou association avec un changement dans la consistance des selles

- **Drapeaux rouges :** Perte de poids, rectorragie, histoire familiale de cancer intestinal, symptômes nocturnes, fièvre, masse abdominale, anémie

- **Traitement:** associe activité physique, recommandations alimentaires, antalgie classique, spasmolytique (mébévérine), laxatif (lactulose), antidépresseur

La **relation médecin-malade** joue un rôle particulier

Question 4

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes au sujet de la prescription de **physiothérapie** ?

- ☒ A. Tous les médecins titulaires d'un FMH peuvent prescrire de la physiothérapie
- ☒ B. Les physiothérapeutes peuvent choisir le type de traitement compte tenu des informations données par le médecin
- ☐ C. Une prescription de physiothérapie peut se faire pour six mois comme pour une ordonnance
- ☐ D. Il n'est pas possible de prescrire deux séances par jour

Prescription de physiothérapie

- La prescription de physiothérapie est un **acte médical**, valable **trois mois**.
- **Prescription :**
 - nom du patient
 - diagnostic
 - nombre de séances; après 4 séries de 9 séances de physiothérapie, le médecin doit justifier sa prescription auprès des assurances
 - deux séances par jour: possible
- Mesures physiothérapeutiques particulières demandées par le **médecin** et adaptées par le **physiothérapeute**
 - ex : mobilisation articulaire active/passive, physiothérapie respiratoire, drainage lymphatique, enseignement exercices à faire à domicile, rééducation du périnée (bio-feed-back)

Schweizer Physiotherapeutischer Verband - Swiss Association of Physiotherapists
 Association Suisse de Physiothérapie - Associazione Svizzera Italiana di Fisioterapia
 CONFEDERATION DES THERAPEUTES PHYSIOTHERAPEUTES DE LA SUISSE
 CONFEDERAZIONE TERAPEUTI FISIOTERAPISTICI DELLA SVIZZERA

MISCELLANEOUS
 COMMISSION DES DROITS
 COMMISSION DES DROITS
 COMMISSION DES DROITS

MISCELLANEOUS (FR)
 ASSOCIATION SUISSE (FR)
 ASSOCIATION SUISSE (FR)

MISCELLANEOUS (DE)
 ASSOCIATION SUISSE (DE)
 ASSOCIATION SUISSE (DE)

Prescription de Physiothérapie

Identité:

Nom _____

Prénom _____

Adresse _____

NPA/Lieu _____

Date de naissance _____

Téléphone privé _____

Employeur _____

NPA/Lieu _____

Téléphone prof. _____

Assureur _____

N° d'ass./acc. _____

Diagnostic:

☐ notification séparée au médecin-conseil selon LaMal

☐ maladie ☐ accident ☐ invalidité

Traitement physiothérapeutique proposé (à remplir par le médecin):

ordonnance: ☐ première ☐ deuxième ☐ troisième ☐ quatrième ☐ traitement de longue durée

But du traitement:

☐ Analgésie/anti-inflammatoire

☐ Amélioration de la fonction articulaire

☐ Amélioration de la fonction musculaire

☐ Proprioception/coordination

☐ Amélioration de la fonction cardio-pulmonaire

☐ Amélioration de la fonction circulatoire

☐ Autres: _____

☐ But particulier

☐ Bandages (Tape)

☐ Instruction

Mesures physiothérapeutiques:
(à compléter par le médecin s'il le désire)

Nombre de traitements: _____ ☐ Traitement à domicile ☐ 2 traitements par jour Contrôle médical après _____ traitements

☐ Location d'appareils: _____

En accord avec le médecin, le/la physiothérapeute peut choisir ou modifier les moyens et méthodes pour atteindre au mieux le but du traitement.

Médecin (Timbre): N° CSDM: _____

Date: _____ Signature: _____

Physiothérapeute (Timbre CSDM): _____

Date: _____ Signature: _____

Remarques: _____

Programme

1. Torticolis (PB)
2. Fibromyalgie
3. Côlon irritable
4. Prescription de physiothérapie
- 5. Polyneuropathies (PS)**
- 6. Grippe**
- 7. Pied plat**
- 8. Herpes-varicelle**
- 9. Furoncle**

Question

Quelle(s) est/sont la ou les cause(s) fréquente(s) à rechercher lorsque un patient se présente avec une **polyneuropathie périphérique** ?

- ☒ A. Une mesure de la glycémie pour rechercher un diabète.
- ☒ B. Une anamnèse ciblée pour rechercher un problème d'alcool.
- ☐ C. Une anamnèse et un examen physique afin d'exclure un accident vasculaire cérébral.
- ☒ D. Un dosage de la TSH pour rechercher une hypothyroïdie.
- ☒ E. Une mesure de la créatinine pour rechercher une insuffisance rénale chronique.

Causes fréquentes de polyneuropathie périphérique

- Aiguë (jours)
Syndrome de Guillain-Barré : prédominance motrice
- Subaiguë (semaines à 1-2 ans)
 - Diabète
 - Abus d'alcool
 - Carence en vitamine B
 - Insuffisance rénale
 - Hypothyroïdie
 - Syndrome paranéoplasique
 - SIDA

Question

Dans quel(s) groupe(s) de la population est-il fortement recommandé de faire une **vaccination contre la grippe** ?

- ☒ A. Les personnes âgées de ≥ 65 ans.
- ☒ B. Les adultes avec maladies cardiovasculaires.
- ☐ C. Les adolescents.
- ☒ D. Les adultes avec un diabète.
- ☒ E. Les travailleurs de la santé.

La vaccination pour la grippe est fortement recommandée dans les groupes à risque suivants

- Les personnes âgées de ≥ 65 ans
- Les adultes avec : maladie cardiovasculaire, maladie pulmonaire, diabète, dysfonction rénale, hémoglobinopathies, immunosuppression.
- Les travailleurs de la santé.
- Les femmes enceintes durant la saison de la grippe.
- Les personnes voyageant dans des zones où l'activité grippale existe ou chez les personnes provenant de zone où il y a actuellement une activité grippale.

Question

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes au sujet des **pieds plats** :

- ☐ A. Le pied plat est une condition caractérisée par un effondrement de la voûte plantaire
- ☐ B. La plupart des personnes souffrant de pieds plats sont asymptomatiques
- ☐ C. Un pied plat est une contre-indication pour effectuer le service militaire
- ☐ D. Les symptômes en rapport avec le pied plat (en pronation) sont principalement la douleur et la boiterie.

Pied plat

- **Pied plat** : effondrement de la voûte plantaire (la semelle du pied est en contact avec le sol de façon complète ou quasi complète) également désignée par les termes pied valgus ou en pronation
- Normal et transitoire chez le jeune enfant (déficiency musculaire du pied)
- Symptômes et signes : douleur, boiterie, difformité, excès d'usure de la chaussure et la fatigabilité. Dans ces situations, la semelle orthopédique est très utile.
- Souvent asymptomatique, le pied plat en général ne représente plus une contre-indication au service militaire.

Question

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes au sujet de la **varicelle**:

- A. Elle est peu contagieuse
- B. La vaccination de la varicelle doit impérativement être proposée aux personnes immunosupprimées ou enceintes.
- ☒ C. La varicelle peut se compliquer d'infections sévères, principalement pulmonaires, en particulier chez l'adulte.
- ☒ D. La varicelle se caractérise par des symptômes généraux précédant de 24 heures une éruption cutanée prurigineuse centrifuge et souvent une atteinte des muqueuses.

Varicelle

- Très contagieuse : 90% des personnes non immunisées et exposées vont développer la maladie.
- Caractéristiques des signes cutanés:
 - exanthème maculeux devenant papulaire puis vésiculaire avant l'apparition des premières croûtes (déjà 24 à 48h après le début de l'exanthème et jusqu'à 1 à 2 semaines après);
 - un rash polymorphe constitué de lésions d'âge différent, siégeant initialement sur la face (y compris le cuir chevelu) et le tronc, puis sur les membres;
 - parfois lésions muqueuses : conjonctives, oropharynx, uro-génitales
- Vaccin: dès 11 ans (si anamn. nég. – adulte séronég. < 40 ans, surtt F)
- Femmes enceintes et patients immunosupprimés: pas de vaccination (vaccin vivant atténué) – immunoglobulines spéc.
- Thrombopénie et att. hépatique transitoire possible
- Complications pulmonaires chez 5-15% des adultes.

Question

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes sont correctes au sujet d'un **furoncle** :

- ☒ A. Un furoncle est un nodule inflammatoire centré par un poil.
- ☐ B. Un furoncle doit toujours être traité par une antibiothérapie systémique
- ☐ C. Un furoncle sur la face doit d'abord être traité par des compresses chaudes et, en cas de non amélioration par un antibiotique.
- ☒ D. Le diabète peut être un facteur favorisant.

Furoncle

- Les furoncles sont des folliculites profondes et nécrosantes qui revêtent l'aspect de nodules inflammatoires surmontés d'une pustule centrée par un poil.
- L'antibiothérapie systémique est associée aux soins locaux dans les cas suivants :
 - Lésions multiples, anthrax= agglomérations de furoncles
 - Lymphangite ou cellulite
 - Localisation médiofaciale
 - Présence d'une infection à MRSA
 - Le patient ne veut pas être traité localement
 - Infection récurrente

Source principale

Allan H. Goroll, Albert G. Mulley "Primary care medicine"
Lippincott Williams&Wilkins Philadelphia 2009